



十全藥品

“十全”安可黴乳膏 Ankorme Cream " S.C. "

衛署藥製字第048032號
G-9138

Butenafine hydrochloride 為Benzyl amine 類抗真菌劑，它具備廣泛之抗寄生性黴菌功能，對於表面性感染之黴菌具有優良的藥效。臨床研究顯示，每天使用一次本品有良好的黴菌治癒及完全治癒的功效。

【成分】Each gram contains:

Butenafine hydrochloride..... 10 mg

【適應症】：

指(趾)間黴菌病(香港腳)、圓癬(體癬)、股癬等皮膚真菌屬黴菌引起之皮膚感染症。

【用法用量】

取適量乳膏塗抹於患部及臨近之部位，輕輕摩擦使乳膏被覆薄層於表面。依不同症狀參照下表使用：

香港腳、指(趾)間黴菌病	一天二次一星期或一天一次四星期
身體、雙手、皮膚皺摺部位之真菌感染	一天一次二星期

本藥須由醫師處方使用。

【藥效藥理】依文獻記載

1. 抗黴菌作用：

(1) 抗黴菌功能評估：

Butenafine有絕佳的抗黴菌功能，不同黴菌菌株之體外最小抑制濃度(MIC)可以下表表示：

菌株	MIC*(mg/m ³)
Trichophyton rubrum	0.007(0.0015~0.025)
Trichophyton mentagrophytes	0.012(0.006~0.025)
Microsporum canis	0.024(0.0125~0.06)
Epidermophyton floccosum	0.016(0.006~0.025)
Malassezia furfur	3.13(1.56~6.25)

*幾何平均(最小濃度~最大濃度)

(2) 趾間黴菌病的治療：

土撥鼠趾間黴菌感染10天後，不同成分1%的乳膏使用20天之後，Butenafine表現出明顯的治療效果。

治療比較*	% of negative cultures
1 % Butenafine cream	88.5
1 % Bifonazole cream	31.3 **
1 % Clotrimazole cream	27.1 **
None	9.4 **

*資料來源"Antimicrobial Agents and Chemotherapy", Nov, 1990 p2250~2253**與Butenafine治療組比較顯著水準P<0.001

2. 皮膚維持性：

預先在實驗土撥鼠背部塗抹1 % Butenafine液，如於24及48小時前塗抹可防止。

黴菌感染直到17天。72小時前的塗抹可防止同期間60 % 感染。在土撥鼠試驗中(n=25)施用2 mg的Butenafine後24、48、72小時的皮膚濃度超過體外抑制T. mentagrophytes所需的濃度(0.012 μg/mL)。

3. 作用機制：

Butenafine抑制Squalene epoxidase的合成，因此干擾黴菌細胞膜成份中的ergosterol之合成。

【體內藥物動態學】依文獻記載

1. 吸收試驗：

健康成人的皮膚表面在500cm²面積上施用Butenafine 1 %，5 g，血漿濃度在12小時內達到最高濃度C_{max}，4.0 mg/mL，半衰期為23.4小時。在重覆投藥試驗中，12小時的血漿濃度略少於單劑量試驗的濃度。

2. 皮膚穿透試驗：

在土撥鼠試驗中，Butenafine 穿透性以表面塗抹 2 mg 劑量，表皮層於 24 小時達到最高濃度 (250~500 $\mu\text{g/g}$)。

臨床試驗：

(1). 臨床有效性：

雙盲試驗於皮膚圓癬患者中，42 位受試者接受 Butenafine 1 % 乳膏與 36 位受試者接受空白試劑比較每日塗抹一次持續二星期的治療。與空白試劑組相較，患者得到 Butenafine 治療的治療率在 14 天時已明顯優於空白對照組 (31 vs 3 %; $p < 0.01$)。Butenafine 治療組第 42 天的治療率可持續改善到 67%，與空白組患者 14% 相較下更有顯著的不同 ($p < 0.0001$)。在雙盲試驗中，使用 Butenafine 1 % Cream 每日二次的患者 (人數 132 人) 在第 8 天與空白試劑組的患者 (人數 139 人) 相較，兩組的趾間足癬患者有明顯的差異性 (43 vs 25 %; $p = 0.021$)，這種狀況在第 42 天時患者間的比較有更顯著的差異 (74 vs 22 %; $p < 0.0001$)。在全部 824 位患者進行的控制式或非控制式臨床比較試驗，對足癬患者有效率為 81.8 %、圓癬患者為 89.4 %、股癬患者為 86.1 %。

(2). 容許度試驗：

根據日本貼布研究基準，Butenafine 並未造成受試者陽性反應 (皮膚刺激性)，結果顯示 Butenafine 對皮膚刺激度非常低。

【使用禁忌】

本品 (Butenafine HCl Cream) 1 % 不應使用於對本品已知或可能有過敏的患者。若已經知道對丙烯胺 (Allylamine) 抗黴菌藥物過敏者應小心使用本品，因為可能有交互作用產生。

【注意事項】

一般事項：

本品只能外用，如果使用本品時會引起過敏反應，須立即停止用藥，並給予適當的治療。適應症應經診斷確認，可將表皮細胞泡製於氫氧化鉀溶液，透過顯微鏡檢查或適當的培養基培養。使用本品應經由醫師處方，並且避免接觸眼睛、鼻子、嘴巴等黏膜組織。

給患者的用藥知識：

患者應該遵循以下說明：

1. 使用本品必須遵循醫師指示。在患部使用乳膏後雙手應予洗淨，避免接觸眼睛、鼻子、嘴巴等處之黏膜。
2. 假如您希望在洗澡後使用本品，必須先將患部充份乾燥。
3. 即使微候已經有明顯改善，必須遵循醫師的治療程序。假如於治療結束後症狀並無改善，甚至症狀有惡化的現象，應立即告知醫師。
4. 如果使用期間發生以下症狀應立即告知醫師：刺激、發紅、發癢、脆化、發腫、滲水。
5. 避免使用壓迫性膠帶，除非經由醫師指示。

【藥品交互作用】

本品與其它引起交互作用的藥品資料尚未完全建立。

【致癌性、致突變性、致畸胎性】

長期致癌性尚未評估。由兩項體外試驗 (Bacterial reverse mutation test 及 Chromosome aberration test) 及一項體內試驗 (Rat micronucleus bioassay) 顯示並無致癌性。繁殖試驗中使用劑量 (150 $\text{gm/m}^2/\text{day}$) 為治療指間黴菌病最大劑量 (15 $\text{gm/m}^2/\text{day}$) 的 10 倍；或是治療股癬、體癬最大劑量 (24 $\text{gm/m}^2/\text{day}$) 的 6 倍，於此劑量下雄性或雌性動物的繁殖能力皆無不良影響。

【懷孕期】

於動物試驗中鼠類及兔類器官發生期施用高於治療劑量的 6~10 倍亦未發現胎兒畸形現象，然而動物的繁殖試驗結果並不完全預測人的反應，因此孕婦使用應謹慎。

【哺乳婦女】

目前尚未得知 Butenafine HCl 是否會排出於母乳中，因為許多藥品會隨著母乳排出，因此哺乳婦女使用時應小心。

【孩童使用】

12 歲以下孩童安全性及效用尚未評估。12~16 歲的患者使用本品與成人無異。

【不良反應】

在臨床試驗中，230 位的患者中有 3 位 (約 1%) 使用本品的皮膚有不良的反應，症狀包括發紅、發癢或情況惡化。在相同試驗中接受空白藥劑組 250 患者有 1 位患者產生嚴重不良反應。一般試驗中不良反應的症狀為接觸性皮膚炎、紅腫、發癢及刺激，發生率在 2% 以下。

【賦形劑】 TEFOSE 63, Myristyl Myristate, CORSTER 5024, Squalane, Cetyl

Alcohol, Dimethicone DC 200/100, Methylparaben, Rte-151038

【儲存】：於 25 °C 以下儲存，應置於孩童無法取得之處。

【包裝】：1000g 以下鋁管裝及塑膠瓶裝。

十全實業股份有限公司

公司：南投市南崗工業區仁和路 27 號

電話：(049) 2254221-3
服務專線：(049) 2254615
訂購專線：0800-491666
傳真：(049) 2254617